CAS CLINIQUE 1 : CRISE DE GOUTTE TYPIQUE

1. Présentation du patient et Énoncé

- **Profil :** Homme de 55 ans.
- **Antécédents :** Hypertension artérielle (HTA) traitée par diurétique thiazidique.
- **Motif de consultation :** Douleur brutale du gros orteil droit (podagre) survenue au cours de la nuit (2ème moitié de la nuit).
- **Signes fonctionnels :** Douleur extrême au moindre contact, pulsatile, insomniante, permanente, atteignant son intensité maximale en quelques heures, accompagnée d'une impotence fonctionnelle totale.
- **Caractère :** Première crise (monoarthrite inaugurale).

2. Données de l'interrogatoire

- **Mode d'installation :** Début brutal, nocturne.
- **Cinétique de la douleur :** Maximale en quelques heures.
- **Facteurs déclenchants identifiés :**
    - Consommation d'un verre de vin la veille.
    - Repas riche (viandes rouges).
    - Prise de diurétique thiazidique.
- **Prodromes éventuels :** Paresthésies, malaise, irritabilité.

3. Examen clinique

- **Examen local (articulation métatarso-phalangienne du gros orteil - MTP1 droite) :**
    - Rougeur intense (+++).
    - Chaleur locale (+++).
    - Tuméfaction articulaire importante.
    - Peau rouge et luisante.
    - Douleur extrême au moindre contact.
    - Impotence fonctionnelle majeure.
- **Examen général :**
    - Température subfébrile possible (38 °C - 38,5 °C).
    - État général conservé.
    - Absence formelle de signes de sepsis / gravité.

4. Bilan biologique initial

- **Uricémie :** 82 mg/L (valeur élevée). *(Rappel : peut être normale ou basse en pleine crise aiguë en raison de la sécrétion d'ACTH et de cytokines uricosuriques).*

- **CRP :** 48 mg/L (augmentée).
- **VS :** 35 mm (augmentée).
- **Créatininémie :** 98 µmol/L (normale).
- **DFG (CKD-EPI) :** 82 ml/min/1,73 m² (normal).
- **NFS :** Normale.
- **Ponction articulaire (indiquée en cas de doute diagnostique) :** Liquide synovial jaune citrin, très inflammatoire (> 5 000 GB/mm³), stérile, mettant en évidence des cristaux d'urate de sodium (forme d'aiguilles, à biréfringence négative).

5. Questions interactives et Réponses

- **Q1 : Quel est le diagnostic le plus probable ?**
  - *Options :* A. Arthrose | B. Polyarthrite rhumatoïde | C. Goutte | D. Arthrite septique
  - **Réponse : C (Goutte / Crise de goutte aiguë).**
- **Q2 : Faut-il doser l'uricémie en urgence ?**
  - *Options :* A. Oui | B. Non
  - **Réponse : B (Non).** L'uricémie n'est pas fiable pendant la phase aiguë et ne doit pas retarder le traitement ; le dosage se fait à distance de la crise.
- **Q3 : Quel traitement en première intention ?**
  - *Options :* A. Allopurinol | B. AINS | C. Antibiotiques | D. Diurétiques
  - **Réponse : B (AINS), si absence de contre-indication.**
- **Q4 : Faut-il arrêter le diurétique ?**
  - *Options :* A. Oui immédiatement | B. Non | C. À discuter secondairement
  - **Réponse : C (À discuter secondairement).**

6. Diagnostics différentiels à éliminer

- Arthrite septique (urgence diagnostique absolue, à écarter jusqu'à preuve du contraire).
- Chondrocalcinose (pseudogoutte / cristaux de pyrophosphate de calcium).
- Arthrose en poussée inflammatoire.
- Polyarthrite rhumatoïde.

7. Prise en charge immédiate

- **Traitement médicamenteux de la crise (dès les premières heures) :**
  - Première intention : AINS à dose efficace sur une courte durée (si pas de contre-indication).
  - Alternative : Colchicine (schéma : J1 : 1 mg à T0, puis 0,5 mg à T0 + 2h ; J2 et J3 : 0,5 mg 2 à 3 fois par jour ; ne pas dépasser 6 mg au total par crise).
  - En cas de contre-indications aux AINS et à la colchicine : Corticoïdes (par voie orale ou intra-articulaire).
- **Mesures non pharmacologiques associées :**
  - Repos et immobilisation de l'articulation atteinte.
  - Application locale de glace.

    - Hydratation adéquate.
- **Évolution :**
    - Sans traitement : la crise dure 7 à 10 jours avec desquamation cutanée terminale.
    - Avec traitement précoce : amélioration en 24 à 48 heures.

8. Erreurs à éviter et Message clé

- Ne pas attendre les résultats biologiques pour traiter la douleur.
- Ne pas débuter un traitement hypouricémiant (allopurinol) en pleine crise aiguë.
- Ne pas éliminer le diagnostic de goutte sur une uricémie normale en crise.
- Ne jamais omettre l'hypothèse d'une arthrite septique.
- **Message clé :** *« Toute monoarthrite aiguë du gros orteil = goutte jusqu'à preuve du contraire. Traiter tôt, adapter au terrain, rechercher les facteurs favorisants et prévenir les récidives. »*

CAS CLINIQUE 2 : INDICATION DU TRAITEMENT DE FOND

1. Présentation du patient et Énoncé

- **Profil :** Homme de 60 ans.
- **Antécédents :** Diabète de type 2, HTA.
- **Traitements en cours :** Metformine, Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC).
- **Motif de consultation :** Douleurs articulaires récidivantes.
- **Histoire :** Survenue de 3 crises de goutte au cours de la dernière année, ayant intéressé successivement le gros orteil puis la cheville (cou-de-pied). Crises favorisées par des repas copieux et la prise d'alcool.

2. Données de l'interrogatoire

- **Fréquence des crises :** 3 crises au cours des 12 derniers mois (critère supérieur ou égal à 2 crises/an).
- **Siège des atteintes :** Gros orteil, cheville.
- **Facteurs déclenchants :** Repas riches en purines, consommation d'alcool.
- **Antécédents lithiasiques :** Aucun antécédent de colique néphrétique ou de lithiase urique.

3. Examen physique (en période intercritique)

- **Examen articulaire :**
    - Articulations libres et indolores en dehors des crises.

    - Absence de tophus visible ou palpable (recherche négative aux pavillons des oreilles, coudes, doigts et tendons d'Achille).
    - Absence de déformations articulaires permanentes.
- **Examen général :**
    - Pression artérielle : 135/85 mmHg.
    - Indice de masse corporelle (IMC) : 30 kg/m² (obésité modérée / surpoids).
    - Absence de signes d'atteinte rénale clinique.

4. Bilan biologique

- **Uricémie :** 90 mg/L (540 µmol/L) (hyperuricémie majeure et persistante).
- **Créatininémie :** 11 mg/L (97 µmol/L).
- **DFG (CKD-EPI) :** 78 ml/min/1,73 m² (fonction rénale préservée / correcte).
- **Glycémie à jeun :** 1,45 g/L (8,0 mmol/L).
- **HbA1c :** 7,6 % (diabète insuffisamment équilibré).
- **Bilan lipidique :** LDL-cholestérol à 1,30 g/L (dyslipidémie associée).
- **CRP :** 6 mg/L (normale en période intercritique).

5. Questions interactives et Réponses

- **Q1 : Ce patient a-t-il une indication de traitement de fond ?**
    - *Options :* A. Non | B. Oui | C. Seulement si tophus | D. Seulement si insuffisance rénale
    - **Réponse : B (Oui).** L'indication est formelle en raison de la récidive des crises (au moins 2 crises par an).
- **Q2 : Quel est le traitement de première intention ?**
    - *Options :* A. Colchicine | B. AINS | C. Allopurinol | D. Corticoïdes
    - **Réponse : C (Allopurinol).**
- **Q3 : Quelle est l'uricémie cible chez ce patient ?**
    - *Options :* A. < 80 mg/L | B. < 70 mg/L | C. < 60 mg/L | D. < 40 mg/L
    - **Réponse : C (< 60 mg/L, soit < 360 µmol/L).** *(Note : la cible est abaissée à < 50 mg/L en cas de tophus volumineux ou de goutte sévère).*
- **Q4 : Faut-il une prophylaxie des crises au début ?**
    - *Options :* A. Non | B. Oui pendant 1 mois | C. Oui pendant 3 à 6 mois | D. Seulement si crise
    - **Réponse : C (Oui pendant 3 à 6 mois).**

6. Conduite à tenir thérapeutique

- **Traitement hypo-uricémiant de fond :**
    - **Allopurinol en 1ère intention** (inhibiteur de la xanthine oxydase).
    - Débuter à faible dose (100 mg/jour) pour minimiser le risque d'effets indésirables graves (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome DRESS).
    - Augmentation progressive de la posologie toutes les 2 à 4 semaines en fonction des contrôles de l'uricémie jusqu'à atteindre l'objectif ("Treat to target").

    - *Alternatives :* Fébuxostat (si intolérance ou contre-indication à l'allopurinol) ou uricosuriques (ex : probénécide, si absence de lithiase et fonction rénale suffisante).
- **Prophylaxie concomitante des crises :**
    - Prescription conjointe de **colchicine à faible dose (0,5 mg 1 à 2 fois par jour)** pendant les **3 à 6 premiers mois**.
    - Justification : la baisse rapide de l'uricémie mobilise les stocks tissulaires et peut déclencher des crises aiguës.
- **Mesures hygiéno-diététiques et métaboliques :**
    - Régime pauvre en purines (diminution des abats, charcuteries, viandes rouges, certains fruits de mer).
    - Réduction stricte de la consommation d'alcool (en particulier la bière).
    - Éviction des boissons sucrées enrichies en fructose.
    - Hydratation abondante.
    - Perte pondérale progressive et optimisation du contrôle du diabète et des facteurs cardiovasculaires.
- **Suivi régulier :**
    - Contrôle de l'uricémie toutes les 2 à 4 semaines au début, puis tous les 2 à 3 mois jusqu'à stabilisation, puis tous les 6 mois.
    - Surveillance de la fonction rénale, du bilan hépatique, de la tolérance clinique et de l'observance.

7. Erreurs à éviter et Message clé

- Ne pas initier le traitement de fond malgré une indication claire (au moins 2 crises par an).
- Débuter l'allopurinol à pleine dose d'emblée.
- Oublier la prophylaxie des crises par la colchicine lors de l'initiation du traitement de fond.
- Interrompre le traitement de fond dès la disparition des symptômes cliniques.
- Négliger le suivi biologique régulier de l'uricémie.
- **Message clé :** *« Tout patient présentant au moins 2 crises par an et une uricémie élevée doit bénéficier d'un traitement de fond pour dissoudre les dépôts, prévenir les récidives et éviter le passage à la chronicité tophacée. »*

CAS CLINIQUE 3 : HYPERURICÉMIE ET INSUFFISANCE RÉNALE

1. Présentation du patient et Énoncé

- **Profil :** Homme de 70 ans.

- **Antécédents :** Insuffisance rénale chronique (IRC) avec un débit de filtration glomérulaire estimé à 40 ml/min/1,73 m² (stade modéré), diabète de type 2, hypertension artérielle (HTA).
- **Traitements en cours :** IEC, aspirine à faible dose (100 mg/j).
- **Circonstance de découverte :** Découverte biologique fortuite d'une hyperuricémie à 85 mg/L (510 µmol/L).
- **Statut clinique :** Patient strictement asymptomatique, aucun antécédent de crise articulaire ni de crise de goutte.

2. Données de l'interrogatoire

- **Absence de symptômes articulaires :** Aucune douleur articulaire passée ou présente, aucun épisode de rougeur ni de tuméfaction.
- **Absence d'antécédent lithiasique :** Pas de lithiase urique connue ni de colique néphrétique.
- **Facteurs de risque et iatrogénie :** Présence d'une insuffisance rénale chronique, HTA, diabète, prise d'aspirine à faible dose (qui augmente la réabsorption tubulaire de l'acide urique via URAT1).
- **Conclusion clinique :** Hyperuricémie asymptomatique isolée sur terrain d'insuffisance rénale.

3. Examen physique

- **Examen articulaire :**
    - Absence de tout signe inflammatoire articulaire (pas de chaleur, ni rougeur, ni tuméfaction, ni douleur).
    - Recherche de tophus strictement négative (pavillons des oreilles, coudes, doigts, tendons d'Achille).
- **Examen général :**
    - Bon état général conservé.
    - Pression artérielle : 135/80 mmHg.
    - IMC : 27 kg/m².
    - Absence de signes cliniques de surcharge ou de décompensation.

4. Bilan biologique

- **Uricémie :** 85 mg/L (510 µmol/L) (élevée).
- **Créatininémie :** 16 mg/L (141 µmol/L).
- **DFG (CKD-EPI) :** 40 ml/min/1,73 m² (insuffisance rénale chronique modérée).
- **Urée :** 0,62 g/L.
- **Glycémie à jeun :** 1,30 g/L (7,2 mmol/L).
- **Cholestérol total :** 2,10 g/L.
- **CRP :** 3 mg/L (normale).

- **Interprétation physiopathologique :** Hyperuricémie d'origine rénale par hypo-excrétion (le rein assure normalement 70 % de l'élimination de l'acide urique ; la réduction du débit de filtration glomérulaire entraîne une rétention uratique).

5. Questions interactives et Réponses

- **Q1 : Ce patient nécessite-t-il une indication de traitement de fond ?**
  - *Options :* A. Oui systématiquement | B. Non | C. Seulement si uricémie > 100 mg/L | D. Oui car insuffisance rénale
  - **Réponse : B (Non).**
- **Q2 : Quel est le principal mécanisme de l'hyperuricémie dans ce cas ?**
  - *Options :* A. Hyperproduction | B. Hypo-excrétion rénale | C. Infection | D. Cause inconnue
  - **Réponse : B (Hypo-excrétion rénale).**
- **Q3 : Quel traitement privilégier en cas de crise chez ce patient ?**
  - *Options :* A. AINS | B. Colchicine à dose normale | C. Colchicine à dose réduite | D. Aucun
  - **Réponse : C (Colchicine à dose réduite)** ou corticoïdes (les AINS sont formellement contre-indiqués chez l'insuffisant rénal).
- **Q4 : Quel est le principal risque si un traitement inadapté est prescrit ?**
  - *Options :* A. Hyperglycémie | B. Toxicité médicamenteuse | C. Infection | D. Anémie
  - **Réponse : B (Toxicité médicamenteuse)** par accumulation liée à l'altération de la clairance rénale.

6. Conduite à tenir recommandée

- **Abstention de traitement médicamenteux hypouricémiant :**
  - Pas de prescription systématique d'allopurinol ou de fébuxostat chez un insuffisant rénal présentant une hyperuricémie asymptomatique isolée (non recommandée par les consensus internationaux tels que l'EULAR ou l'ACR).
- **Mesures hygiéno-diététiques :**
  - Réduction des apports alimentaires riches en purines.
  - Limitation de la consommation de boissons alcoolisées.
  - Hydratation adéquate pour maintenir un débit urinaire suffisant.
  - Perte de poids modérée si nécessaire et activité physique régulière.
- **Prise en charge globale du terrain :**
  - Contrôle strict de la pression artérielle et de la glycémie.
  - Optimisation des thérapeutiques des comorbidités.
- **Surveillance continue :**
  - Surveillance clinique (dépistage précoce d'une éventuelle première crise articulaire ou de tophus).
  - Surveillance biologique régulière de la fonction rénale (créatinine, DFG) et de l'uricémie.
- **Règles thérapeutiques si une crise survenait ultérieurement :**

    - Proscrire les AINS (risque d'aggravation de l'insuffisance rénale).
    - Privilégier les corticoïdes (oraux ou intra-articulaires) ou la colchicine à dose adaptée/réduite (ex: 0,5 mg tous les 2 jours ou 0,5 mg/jour selon la clairance).
- **Règles si un traitement de fond devenait nécessaire (ex : crises récidivantes, tophi, lithiases, ou uricémie très sévère > 100 mg/L) :**
    - Allopurinol débuté à très faible dose (50 à 100 mg/j) avec titration lente selon le DFG.
    - Fébuxostat possible sans adaptation posologique en cas d'IRC légère à modérée.
    - Contre-indication formelle des uricosuriques si le DFG est inférieur à 50-60 ml/min ou en présence de lithiase.

7. Erreurs à éviter et Message clé

- Traiter systématiquement un chiffre d'uricémie élevé en l'absence de symptômes.
- Administrer des AINS en présence d'une insuffisance rénale.
- Ne pas réduire la posologie de la colchicine ou de l'allopurinol chez le sujet âgé insuffisant rénal (risque toxique mortel).
- Négliger les interactions médicamenteuses et l'impact des comorbidités cardiovasculaires.
- **Message clé :** *« Chez l'insuffisant rénal, l'hyperuricémie isolée ne nécessite pas de traitement médicamenteux systématique. La décision thérapeutique repose sur les symptômes, la présence de complications et l'évaluation globale du terrain : il faut traiter le patient et non le chiffre. »*